



Anamnesis y exploración psicopatológica en el paciente con síntomas psicóticos

M. Gómez García* e I. Moreno Alonso

Unidad de Psiquiatría. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid. España.

Palabras Clave:

- Anamnesis
- Exploración
- Psicosis

Keywords:

- Anamnesis
- Examination
- Psychosis

Resumen

Cuando hablamos de clínica psicótica no solo nos referimos a la esquizofrenia, sino también a un grupo de trastornos con etiologías heterogéneas que incluye a pacientes con presentaciones clínicas diferentes. La sintomatología psicótica podemos agruparla en varios grupos: síntomas positivos, negativos y cognitivos.

Cuando nos encontremos en consulta con un paciente psicótico, deberemos hacer una anamnesis adecuada, en la que pondremos énfasis en la repercusión emocional de los síntomas y de los acontecimientos vitales del sujeto. En este sentido, la herramienta fundamental en la entrevista es la exploración psicopatológica, que consiste en explorar diferentes áreas de la persona (aspecto, actitud, conducta, conciencia, orientación, memoria y atención, psicomotricidad, lenguaje, humor y afectividad, pensamiento, cognición e inteligencia, hábitos fisiológicos y repercusiones somáticas). Con todo ello, podremos valorar si el paciente presenta un juicio de realidad conservado o alterado.

Abstract

Case history and psychopathological examination in patients with psychotic symptoms

When we talk of psychotic symptoms, we not only refer to schizophrenia, but also to a group of disorders with varied etiologies that include patients with different clinical presentations. Psychotic symptoms can be classified in several groups: positive symptoms, negative symptoms, and cognitive symptoms.

When we come across a patient with psychosis in a consultation, we must take a proper case history, placing emphasis on the emotional repercussion of his/her symptoms and the subject's life events. In this regard, the fundamental tool in the interview is a psychopathological examination, which consists of examining different aspects of the person (appearance, attitude, behavior, awareness, orientation, memory and attention, psychomotricity, language, mood and emotion, thinking, cognition and intelligence, physiological habits, and somatic repercussions). With all of this, we can assess whether the patient has a view of reality that is preserved or altered.

Introducción

Aunque se habla de esquizofrenia como si fuese una sola enfermedad, probablemente comprende un grupo de trastornos con etiologías heterogéneas, y esto incluye a pacientes cuyas presentaciones clínicas, respuesta al tratamiento y evolución de la enfermedad son distintos¹.

Los signos y síntomas son variables e incluyen cambios en la percepción, la emoción, la cognición, el pensamiento y el comportamiento, englobándose por síntomas positivos (ideas delirantes, alucinaciones), negativos (anhedonia, apatía, abulia, aplanamiento afectivo, alogia, retraimiento social) y cognitivos (alteraciones de la atención, concentración o memoria)² (tabla 1). La expresión de estas manifestaciones es diferente en cada paciente y varía con el tiempo, pero el efecto de esta enfermedad es siempre grave y, normalmente, prolongado¹.

Con una prevalencia del 1%¹, suele empezar antes de los 25 años de edad, persistiendo durante toda la vida y afectando

*Correspondencia

Correo electrónico: marta.gomez.garcia@salud.madrid.org

TABLA 1

Síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia

Síntomas positivos	Síntomas negativos
Alucinaciones	Pobreza del lenguaje y pensamiento (alogia)
Ideas delirantes	Bloqueos del pensamiento
Trastornos formales del pensamiento (incoherencia, descarrilamiento, tangencialidad y falta de lógica)	Embotamiento o aplanamiento afectivo
Conducta extravagante	Retraimiento social
Catatonía	Escaso autocuidado
	Apatía
	Anhedonia
	Abulia (pérdida de motivación para la realización de alguna actividad)

Adaptada de Vallejo Ruiloba J¹.

a personas de todas las clases sociales. Es importante señalar que no existe ningún síntoma o signo patognomónico, ya que todo signo o síntoma observado en esta enfermedad puede presentarse en otros trastornos psiquiátricos y neurológicos¹. La evolución característica clásica de la esquizofrenia sigue un curso de exacerbaciones y remisiones¹. Tras el episodio psicótico agudo, el paciente se recupera gradualmente y, a partir de entonces, puede retomar su actividad con relativa normalidad durante un período de tiempo dilatado¹. A pesar de ello, cada recaída en la psicosis provoca un deterioro posterior consecuencia del grado de actividad basal¹.

Muchas enfermedades médicas, aparte de las mentales, y una gran diversidad de sustancias pueden provocar síntomas psicóticos y catatónicos¹. Para llegar al diagnóstico de un paciente con síntomas psicóticos, se debe realizar una adecuada detección para descartar procesos orgánicos¹.

Tras excluir el origen somático de los síntomas, iniciaremos una entrevista psiquiátrica. Esta es la herramienta fundamental para poder alcanzar una orientación diagnóstica adecuada y, de ahí, poder trazar un plan de tratamiento, siendo también en muchos casos *per se* un acto terapéutico^{1,2}. Se compone de dos partes^{1,2}:

1. Anamnesis. Similar a la entrevista médica general; sin embargo, enfatiza más en la repercusión emocional de los acontecimientos vitales, en las relaciones interpersonales y en la adaptación asocial del individuo a lo largo de su vida para entender al paciente de forma multidimensional como persona¹.

2. Examen mental^{1,2}. Este aspecto será tratado más detalladamente a continuación.

Exploración del estado mental

La exploración psicopatológica es la parte de la entrevista psiquiátrica en la que se explora el estado mental^{1,4}. Conviene seguir una sistemática organizada, aunque flexible, de diferentes áreas^{1,2} (tabla 2), teniendo en cuenta su interrelación, ya que pueden verse afectadas entre sí y cambiar la orientación diagnóstica⁴.

A continuación, se hace un breve resumen por apartados de la exploración psicopatológica general, enfatizando aspectos característicos del paciente psicótico.

TABLA 2

Resumen de la exploración psicopatológica por apartados

Aspecto, actitud y conducta
Conciencia
Orientación
Memoria y atención
Psicomotricidad
Lenguaje
Humor y afectividad
Pensamiento
Sensopercepción
Cognición, inteligencia
Hábitos fisiológicos y repercusiones somáticas
Juicio, introspección y voluntad

Adaptada de Vallejo Ruiloba J¹.

Aspecto, actitud y conducta

Aspecto: presentación, arreglo, limpieza corporal y forma de vestir^{1,2}. Puede ser cuidado y acicalado, aunque no es infrecuente que presenten un aspecto descuidado o extravagante, fundamentalmente en momentos de descompensación aguda^{1,2}.

Actitud: colaboradora, hostil, defensiva, suspicaz, perpleja, etc.^{1,2}.

Conducta: desinhibida, desorganizada (la desorganización del pensamiento suele estar más presente en fases de descompensación aguda)^{1,2}.

Conciencia

Las alteraciones en la conciencia pueden ser cuantitativas o cualitativas.

Las alteraciones cuantitativas de la conciencia (nivel de vigilia) son¹⁻⁴:

Elevación del nivel de conciencia: hipervigilia

Vivencia de claridad de conciencia, pudiendo asociarse con un aumento de la actividad motora y verbal^{1,4,5}.

Disminución del nivel de conciencia

Se pueden clasificar según su grado:

1. Letargia, somnolencia o sopor. Dificultad para mantener la alerta y la atención, a pesar del esfuerzo sostenido por el sujeto¹.

2. Obnubilación. Alteración más profunda en la que es difícil extraer al individuo de ese estado y, cuando se logra, este se muestra confuso y desorientado¹. Es habitual que se alternen síntomas de irritabilidad y excitación con somnolencia³.

3. Estupor. Estado en el que el sujeto permanece ajeno o distante del entorno, no reacciona, permanece inmóvil e incluso mutista¹. En estos casos, para alcanzar un ligero estado de alerta es necesaria una potente estimulación^{1,4}.

4. Coma. Formas prolongadas de suspensión global de conciencia^{1,4}.

TABLA 3

Formas de desorientación (Berrios)

Desorientación orgánica	Desorientación masiva en tiempo y espacio
Doble orientación	«Orientación errónea delirante» o «contabilidad doble» Orientación simultánea o alternativamente con parámetros normales y anormales (por ejemplo, alucinaciones, delirios)
Falsa orientación	«Orientación confabulada» Orientación únicamente con parámetros patológicos

Adaptada de Vallejo Ruiloba J¹.

Orientación (espacio, tiempo y persona)

La orientación en el tiempo es la más vulnerable, por ser la más cambiante^{1,3,4}. German E. Berrios (1982) propuso 3 formas de desorientación que aparecen reflejadas en la tabla 3¹.

Atención

En cuanto a la atención, encontramos:

1. Aumento del nivel de atención (hiperprosexia)^{1,4}. Clínicamente se observa un cambio continuo en la focalización de la atención (distrailidad)⁴.

2. Disminución del nivel de atención (hipoprosexia)^{1,4} o abolición (aprosexia)⁴.

Memoria

Se describen varios conceptos relevantes de alteraciones en este aspecto, aunque no son especialmente característicos de cuadros psicóticos³.

Amnesia retrógrada: incapacidad para recuperar información previa al inicio del cuadro^{1,3} y amnesia anterógrada: incapacidad para almacenar nueva información posterior al inicio del cuadro^{1,3}.

Psicomotricidad

Alteraciones cuantitativas

Distinguimos entre:

1. Aumento: inquietud, agitación¹.

2. Disminución: a) inhibición¹; b) negativismo, oposición ante cualquier movimiento que se le ordene que puede ser pasivo (actitud sistemática de oposición) o activo (hacer lo contrario de lo que se le ordena)^{1,5}; c) rigidez catatónica, asunción voluntaria de una postura rígida en la que el sujeto se resiste a cualquier esfuerzo a ser movido⁵ y d) acinesia, ausencia total de actividad motora y psíquica⁵.

Alteraciones cualitativas

Las alteraciones cualitativas son:

1. Esterotipia: repetición continuada e innecesaria de movimientos concretos sin una finalidad^{1,4}.

2. Manierismo: posturas o movimientos voluntarios realizados de forma repetida que son tan pronunciados, extravagantes o afectados que al ser observados resultan inusuales⁵.

3. Catalepsia o «flexibilidad cérica»: anormal conservación de la postura que se mantiene indefinidamente después de haber sido manipulada por el observador^{1,4}. Suele cursar con rigidez cérica de las extremidades⁶.

4. Ecopraxia: repetición en eco de los movimientos realizados por el examinador⁴.

5. Cataplejía. Pérdida momentánea e involuntaria del tono muscular, con mantenimiento del nivel de conciencia⁵.

6. Corea: flujo continuo de movimientos involuntarios, buscos, breves y de distribución aleatoria e impredecible⁵.

7. Temblor: movimientos rítmicos, involuntarios y regulares que aparecen en una parte del cuerpo alrededor de un punto fijo¹.

8. Tics: movimientos rápidos, repetitivos en el mismo grupo muscular, involuntarios e irregulares en el tiempo¹.

9. Distonías, discinesias, acatisia, automatismos, etc.^{1,2}.

Es importante saber que el tratamiento con neurolepticos puede provocar síntomas a nivel motor. Estos son conocidos como síntomas extrapiramidales. Entre ellos, destacan: acatisia (incapacidad de estar sentado), parkinsonismo (temblor, rigidez, hipertonía corroborada por el «signo de la rueda dentada», bradicinesia, sialorrea, bloqueo postural y oscilaciones pendulares) y distonía aguda (hipertonía de los músculos y presencia de opistótonos-afección en la cual la persona sostiene su cuerpo en una posición anormal)⁷.

Lenguaje

Dentro del lenguaje existen varias dimensiones a valorar, entre las que se encuentran las siguientes:

1. Coherencia. Coherente o incoherente¹.

2. Fluidez. Fluido, logorrea o verborrea, presión del habla (incremento de la cantidad de lenguaje espontáneo), latencia de respuesta, mutismo¹.

3. Direccionalidad del discurso. Circunstancialidad: divagación innecesaria en detalles e ideas inapropiadas antes de comunicar la idea central². Tangencial: respuesta a una pregunta de un modo indirecto o irrelevante, perdiendo la idea central^{1,3,4}. Descarrilamiento: asociaciones laxas de ideas^{1,3,4}.

4. Características. Empobrecido¹, sobreelaborado¹, prolijo (sobreabundancia de detalles)⁵.

5. Tono de voz. Monótono, apagado, elevado¹.

Los trastornos del lenguaje pueden clasificarse en función de su alteración:

1. Del ritmo: taquifemia o taquifasia, bradifemia o bradifasia^{1,2,4}, espasmofemia, disfemia o tartamudez^{1,4}, habla interrumpida o rota (ruptura del discurso de forma brusca)³.

2. Iterativos o esterotipias verbales. Ecolalia: repetición de las últimas palabras o frases que van dirigidos al paciente o que son verbalizados en su presencia^{1,3,4}. Palilalia: repetición involuntaria de la última palabra de la frase varias veces seguidas¹. Verbigeración: repetición incesante, carente de sentido y de forma automatizada de las mimas palabras o frases¹.

3. De la significación. Neologismos: creación y uso de palabras sin un significado generalmente aceptado, a las que

el paciente da una significación concreta¹⁻⁴. Simbolismo: utilización de palabras conocidas a las que se les aplica un significado diferente⁴. Ensalada de palabras (o esquizoafasia)^{1,4}: conexiones incoherentes o incompresibles de palabras que no corresponden a ninguna regla gramatical y sin significado aparente¹.

4. De la articulación: disartria, dislalia, disfonía¹.

5. Afasias: más frecuentes en patologías de origen neurológico¹.

Esfera afectiva

Conjuntamente en esta dimensión se suele valorar la presencia y el grado de ansiedad (psíquica y somática)¹.

Las alteraciones sintomáticas de la afectividad más relevantes son:

1. Aplanamiento afectivo: ausencia o casi ausencia de cualquier signo de expresión afectiva^{1,2}.

2. Embotamiento afectivo: reducción significativa de la intensidad de la expresión emocional¹.

3. Afecto restringido: reducción de la gama e intensidad de la expresión emocional¹.

4. Labilidad emocional: cambios bruscos, repetidos y rápidos en el afecto¹.

5. Disforia: estado de ánimo desagradable con predominio de la sensación de malestar^{1,2}.

6. Paratimia o inadecuación afectiva¹.

7. Apatía, anhedonia, rigidez afectiva, ambivalencia o ambicia¹.

Pensamiento

Dentro de la dimensión del pensamiento, las alteraciones pueden aparecer en la forma o en el contenido del mismo^{1,2}.

Alteraciones en la forma del pensamiento

Las alteraciones más relevantes se describen en la tabla 4.

Alteraciones en el contenido del pensamiento

El protagonista de esta esfera es el delirio o la ideación delirante¹⁻⁴:

Ideación delirante primaria. Creencia falsa, fija y persistente, incorregible e irreductible y que aparece sin un estímulo externo apropiado. No es influenciable por la experiencia, se establece por vía patológica y no se explica por valores sociales, culturales, religiosos o de pertenencia a un grupo. Es incomprensible psicológicamente y no se deriva de otros síntomas o sucesos de la vida cotidiana^{1,3}.

Percepción delirante. Se presenta cuando el paciente recibe una percepción normal que es interpretada posteriormente con un significado delirante y tiene un enorme significado personal³.

Idea delirante secundaria o deliroide. Al igual que la idea delirante primaria, es una creencia falsa, irreductible y fija,

TABLA 4

Alteraciones en la forma del pensamiento

Fluidez	Taquipsiquia, bradipsiquia ¹
Direccionalidad	Circunstancial ^{1,2} Tangencial ^{1,2} Ideofugal: gran aceleración del pensamiento con asociación continua entre ideas y cambio constante de temática (más frecuente en cuadros maniformes) ^{1,2} Disgregado: pérdida de la idea directriz como consecuencia de la rotura de asociaciones normales, sin conexión lógica ¹
Otras alteraciones	Alogia: empobrecimiento del pensamiento expresado mediante un vacío de contenido, típico de sintomatología negativa de esquizofrenia ^{1,2} Pensamiento concreto, perseverante, asociación rítmica ¹

pero en cambio surgen en relación con otros trastornos psiquiátricos o no psiquiátricos^{1,3}. Su contenido es parcialmente comprensible en el contexto vivencial del paciente^{1,3}. Los más importantes dentro de este grupo son los relacionados con los trastornos afectivos^{1,3}.

Las ideas delirantes también pueden clasificarse según su contenido (tabla 5).

Existen otras alteraciones en el contenido del pensamiento que, aunque no son características de los cuadros psicóticos^{1,2}, puede resultar interesante conocerlas para poder distinguirlas de los delirios.

Ideas sobrevaloradas. Creencias, no convicciones, que ocupan un lugar central en la vida de la persona, comprensibles a la luz de la historia personal del paciente, con un marcado tono afectivo y con una persistencia más allá de lo razonable^{1,3}. No las considera como absurdas, a diferencia de las ideas obsesivas, y sí pueden rebatirse con argumentos adecuados, a diferencia de las ideas delirantes¹.

Ideas obsesivas. Ideas, pensamientos, imágenes o impulsos repetitivos, egodistónicos que el paciente generalmente reconoce como absurdos e irracionales, que se imponen al paciente y generan gran ansiedad^{1,2}. Pueden acompañarse o no de rituales o conductas compulsivas². Algunos adolescentes pueden sufrir un inicio repentino de comportamientos típicos del trastorno obsesivo-compulsivo como parte del cuadro prodrómico de la esquizofrenia¹.

Ideas fóbicas

Temor angustioso y miedo desproporcionado y persistente provocado por objetos o situaciones en teoría no peligrosos, reconociéndolo el paciente como irracional¹.

Sensopercepción

Las alteraciones sensoperceptivas más características de la esquizofrenia son las alucinaciones auditivas¹⁻⁴. A pesar de esto, se realiza un resumen global de las alteraciones en la esfera de la sensopercepción para poder diferenciarlas adecuadamente. Pueden clasificarse como distorsiones o como errores sensoperceptivos:

TABLA 5
Alteraciones en la forma del pensamiento según el contenido del delirio

Tipo de delirio ¹	Explicación
Referencia	El sujeto tiene el convencimiento de que todo lo que sucede en el mundo tiene un significado para él
Persecución	Los pacientes creen que están siendo vigilados, espiados, calumniados u hostigados
Culpa, ruina	La persona cree que va a perder una gran cantidad de dinero, propiedad o posición social
Somático-hipocondríaco	El paciente cree que padece una afección médica
Celotípico	Creencia fija de ser engañado por la pareja, aunque exista evidencia en contra
Nihilista	Delirio de Cotard Partes o funciones del organismo han desaparecido, pudiendo llegar a pensar que él mismo desaparece y negar la existencia de todo ^{1,4}
Infestación	Síndrome de Ekbohm o síndrome de la caja de cerillas Cree estar infestado por parásitos, sintiéndolos correr por su piel y afirmando verlos en ocasiones ⁴
Megalomaniaca o de grandeza	El individuo tiene una idea exagerada de su importancia, capacidades o conocimientos
Religioso o místicos	La persona cree que tiene una misión de carácter religioso
Erotomaniaco	Delirio de Clérembault ¹ El sujeto considera que otro está enamorado de él
De significación	El paciente encuentra significados especiales en hechos cotidianos, recibe información a través de ellos que solo él puede descifrar ¹
Fantásticos	Físicamente imposibles (extraterrestres, viajes astrales, etc.); en este grupo se incluirían los delirios parafrénicos ¹
Falsa identificación	Síndrome de Capgras o ilusión de Sosias: creencia de que una persona próxima al paciente ha sido reemplazada por un impostor ^{1,3,4} Síndrome de Fregoli: al contrario, el paciente identifica falsamente a desconocidos pensando que sí los conoce ^{1,3,4}
Alteraciones en la experiencia del pensamiento (vivencia del Yo)	Difusión del pensamiento: el paciente experimenta de forma pasiva que sus pensamientos se difunden fuera de su mente y pueden ser captados y conocidos por otros ¹ Inserción o imposición del pensamiento: el paciente no percibe sus pensamientos como propios, sino que los experimenta como extraños y como si hubiesen sido insertados en su mente, pensando lo que otros desean ¹ Robo del pensamiento: el paciente cree que alguna fuerza externa le ha sacado los pensamientos de su cabeza, experimentándolo como un robo ¹ Lectura del pensamiento: el paciente vivencia que los demás pueden leer su mente ¹ Fenómenos de control o de influencia: sensación subjetiva de estar bajo control de alguna fuerza externa o persona que de alguna forma (pueden ser <i>chips</i> , micrófonos, etc.) modifican su mente ¹
Otros: delirio compartido, delirio inducido o <i>folie à deux</i>)	Delirio compartido por terceras personas, generalmente familiares o allegados del paciente ^{1,2}

Distorsiones perceptivas o sensoriales

Según la intensidad tenemos hiperestesia, hipoestesia, anestesia⁵.

Las metamorfopsia son distorsiones en el tamaño, como la dismegalopsia (micropsia o macropsia)^{1,5} y/o en la forma, como la dismorfopsia⁵. Si estas distorsiones afectan al propio cuerpo se denominan autometamorfopsias¹.

Las ilusiones (alteración en la estructuración de estímulos ambiguos³) son una percepción inadecuada de un estímulo concreto, en el que la percepción final no se corresponde con las características objetivas del estímulo⁵. Distinguimos entre:

1. Las desencadenadas por emociones se denominan catatímicas⁶.

TABLA 6
Clasificación de las alucinaciones según su modalidad sensorial

Clase	Subtipo
Auditiva	Acoasmas (simples), fonemas (complejas), en tercera o segunda persona, imperativas, etc. ⁶ Destacan: eco del pensamiento, voces dialogando entre sí, voces comentadoras de la conducta del sujeto ^{3,4} Más frecuentes en psicosis no orgánicas del adulto, fundamentalmente en la esquizofrenia ^{1,2}
Visual	Simples: fotopsias o fotomas ⁵ Complejas: tamaño normal, liliputienses o gulliverianas Más frecuentes en <i>delirium</i> , psicosis orgánicas o tóxicas ¹
Olfativa	
Gustativa	
Táctil o háptica	Activa, pasiva ⁵ Térmicas, hídricas, parestesias, formicación ⁵ (percepción de insectos o pequeños animales por debajo o encima de la piel que puede orientar a intoxicación por cocaína ³)
Somáticas, corporales, viscerales o cenestésicas	
Cinestésica	

Adaptada de Vallejo Ruiloba J¹.

2. Las desencadenadas por deseos o fantasía se denominan desiderativas o paraeidolias (por ejemplo, las formas de las nubes, el test de manchas como el test de Rorschach)⁶.

La desrealización y la despersonalización pueden aparecer en fases prodrómicas de la esquizofrenia³ o en estados de ansiedad intensos como clínica disociativa²:

1. Desrealización: definido por Jaspers como el sentimiento de extrañeza extrema que acompaña a la percepción de realidades conocidas⁴. El entorno aparece como irreal, extraño, nebuloso^{2,3}.

2. Despersonalización: sentimiento de extrañeza sobre la percepción de sí mismo, de su propio cuerpo o de partes del mismo²⁻⁴.

Errores perceptivos

Alucinaciones. Percepción aparente de un objeto en el espacio exterior, cuando no existe el real correspondiente, con absoluto convencimiento de realidad¹. Se pueden clasificar según su modalidad sensorial (tabla 6).

Alucinosis. Percepción de un objeto irreal en el mundo exterior, con conciencia de irrealidad^{5,6}. Frecuentes en cuadros de abstinencia alcohólica².

Pseudoalucinaciones. Percepción de un objeto irreal únicamente en el espacio interior, vivenciándose como real^{1,5}.

Alucinaciones hipnagógicas. Alucinaciones generalmente de tipo visual que pueden presentarse antes de dormirse⁴.

Alucinaciones hipnopómpicas. Alucinaciones generalmente de tipo visual que pueden presentarse al despertarse del sueño⁴.

En la tabla 7 se esquematizan las diferencias entre alucinación, pseudoalucinación, alucinosis e ilusión⁵.

TABLA 7

Esquema de las alteraciones perceptivas

	Objeto real	Convencimiento de realidad	Espacio de la percepción
Alucinación	No	Sí	Exterior
Pseudoalucinación	No	Sí	Interior
Alucinosis	No	No	Exterior
Ilusión	Sí	Sí	Exterior

Adaptada de Manual APIR⁵.**Cognición e inteligencia**

En pacientes con esquizofrenia, el deterioro cognitivo es un factor pronóstico del nivel de funcionamiento más descriptivo que la propia gravedad de los síntomas psicóticos¹. Los pacientes con esquizofrenia suelen manifestar un déficit cognitivo variable en las áreas de atención, función ejecutiva, memoria de trabajo y memoria episódica¹.

Hábitos fisiológicos y quejas somáticas**Sueño**

Insomnio: conciliación, mantenimiento, despertar precoz, global; hipersomnias: incremento del número de horas de sueño e hipersomnias diurnas, y alteraciones cualitativas: pesadillas, terrores nocturnos, sonambulismo.

Apetito y peso

Hiporexia, anorexia, hiperfagia, conductas restrictivas, conductas purgativas, conductas compensatorias, conductas alimentarias anómalas.

Pérdida o incremento de peso.

Otros

Conducta y deseo sexual, astenia y quejas somáticas.

Juicio, introspección y voluntad

Por lo general, una de las características de los pacientes con esquizofrenia es que tienen una escasa conciencia de la gravedad y de la naturaleza de su enfermedad que tiene como consecuencia un escaso cumplimiento terapéutico^{1,2}.

Responsabilidades éticas

Protección de personas y animales. Los autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datos. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informado. Los autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Conflicto de intereses

Los autores declaran:

Que este artículo es original e inédito, y no se encuentra en proceso de evaluación por ninguna otra revista científica.

Que los autores no tienen ningún conflicto de intereses para la realización de esta actualización.

Que se han tenido en cuenta las instrucciones y las normas de publicación de la revista.

Que todos los autores han leído y han aprobado el manuscrito, y que los requisitos para la autoría se han cumplido.

Que todos los autores han cumplido con sus obligaciones de autor incluidas en estas normas, entre ellas con las responsabilidades éticas; protección de personas y animales; confidencialidad (consentimiento informado) y privacidad.

Que el artículo no ha sido previamente publicado en otra revista (publicación redundante o publicada) y que se está en posesión de todos los derechos.

Bibliografía

● Importante ●● Muy importante

- ✓ Metaanálisis
- ✓ Ensayo clínico controlado
- ✓ Epidemiología
- ✓ Artículo de revisión
- ✓ Guía de práctica clínica

- Vallejo Ruiloba J. Introducción a la psicopatología y la psiquiatría. 8ª ed. Barcelona: Elsevier; 2015.
- Sadock B, Sadock V, Ruiz P. Sinopsis de Psiquiatría. Ciencias del comportamiento/Psiquiatría clínica Kaplan&Sadock. 11ª ed. Barcelona: Wolters Kluwer; 2015.
- Oyebo F. SIMS. Síntomas mentales. Manual de psicopatología descriptiva. 5ª ed. Barcelona: Elsevier; 2015.
- Eguiluz Uruchurtu I, Segarra Echebarria R. Introducción a la psicopatología: una visión actualizada. 3ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2019.
- Manual APIR de Evaluación Psicológica. 3ª ed. 2019.
- López S. Diccionario de psicología y psiquiatría. 2ª ed. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2015.
- Martínez-Hernández O, Rodríguez-Fajardo X, Almeida-Fernández E, Moreira-Rodríguez O, Martínez-Urra F. Extrapiramidal syndrome induced by neuroleptics. Revista Médica Electrónica. 2006;28(3).